Examen Tipo Test - OpoGen

Número de preguntas: 10

1. En relación con la lista de verificación quirúrgica, ¿quién es normalmente el encargado de realizar los controles de seguridad durante la operación?

A) El cirujano principal, de forma exclusiva.

B) El anestesista, por su competencia sobre la vía aérea.

C) El enfermero circulante, sin perjuicio de que cualquier clínico participante pueda chequearla.

D) El responsable de calidad del centro hospitalario.

2. Según el texto, ¿a qué se atribuye la mayor probabilidad de efectos adversos en países en vías de desarrollo con economías en transición?

A) Exclusivamente a la falta de motivación del personal sanitario.

B) Al mal estado de las infraestructuras, la calidad de los medicamentos, los equipos, el control de infecciones y la actuación deficiente del personal sanitario.

C) Únicamente al incremento del número de ingresos hospitalarios.

D) A la aplicación de estrategias de seguridad importadas de otros sistemas sanitarios.

3. ¿Qué conclusión extrajeron Bates et al. en sus estudios sobre los efectos adversos relacionados con los medicamentos?

A) Que la mayoría de los efectos adversos se debían a errores de prescripción médica.

B) Que aproximadamente un 40% de los efectos adversos estaban relacionados con la administración.

C) Que los efectos adversos se reducían con listados de buenas prácticas en cirugía.

D) Que el sexto correcto eliminaba los errores de administración.

4. De acuerdo con el texto, ¿a qué se denomina el «sexto correcto» en la administración de medicamentos?

A) A la comprobación de la caducidad del fármaco antes de su administración.

B) Al registro de la administración en la historia clínica.

C) A la verificación de la esterilidad del material de administración.

D) A la confirmación de la identidad del profesional que administra.

5. Conforme al material, ¿cuál es el papel de los sistemas sanitarios en relación con las prácticas seguras?

A) Sustituir a los profesionales en la prestación directa de los cuidados.

B) Proporcionar herramientas que faciliten el desarrollo, la evaluación y seguimiento de las prácticas seguras, instaurándolas en los centros y unidades.

C) Limitarse a registrar los efectos adversos una vez producidos.

D) Delegar en las organizaciones internacionales la implantación de dichas prácticas.

6. Según el material, ¿cuál es el objetivo único y prioritario de las estrategias para ofrecer seguridad en el paciente?

A) Aumentar el número de profesionales sanitarios en las unidades.

B) Mejorar la calidad asistencial proporcionando cuidados seguros y disminuyendo las posibles incidencias.

C) Reducir el gasto sanitario derivado de los ingresos hospitalarios.

D) Homologar los protocolos con los de países en vías de desarrollo.

7. ¿Cuál de los siguientes ítems corresponde a la segunda fase de la lista de verificación, esto es, la posterior a la inducción anestésica y anterior al cierre de la herida?

A) Comprobar si el paciente presenta una vía aérea difícil o riesgo de aspiración.

B) Confirmar que el consentimiento informado está firmado.

C) Comprobar si se ha realizado profilaxis antibiótica.

D) Confirmar el sitio quirúrgico antes de la inducción.

8. Según el manual de la OMS de verificación de la seguridad quirúrgica, ¿en qué fase se comprueba la colocación del pulsioxímetro?

A) En la fase posterior a la inducción anestésica y anterior al cierre de la herida.

B) En la fase previa a la inducción de la anestesia.

C) En la fase de cierre de la herida quirúrgica.

D) En cualquiera de las tres fases, siempre que lo confirme el enfermero circulante.

9. Según el material, ¿en qué escalón de la pirámide de necesidades humanas de Abraham Maslow se sitúa la necesidad de seguridad?

A) En el primero, junto a las necesidades fisiológicas.

B) En el segundo, una vez suplidas las necesidades fisiológicas.

C) En el tercero, por encima de las necesidades de afiliación.

D) En el cuarto, vinculado a las necesidades de estima.

10. De acuerdo con las investigaciones citadas en el material, ¿qué porcentaje de los ingresos hospitalarios se atribuye a errores con la medicación?

A) Entre el 0,1 y el 1 %.

B) Entre el 1 y el 10 %.

C) Entre el 10 y el 25 %.

D) Entre el 25 y el 50 %.

Hoja de Respuestas Correctas

1. C
2. B
3. B
4. B
5. B
6. B
7. C
8. B
9. B
10. B